

Síndromes Febris

Vamos conversar hoje sobre síndromes febris, um tema absolutamente essencial para quem vai prestar prova de residência médica no Brasil. Imagine o cenário clássico: você está de plantão numa UPA em plena epidemia de dengue — evento canônico no nosso país — e chega mais um caso. Mulher jovem, 20 anos, febre e cefaléia há três dias. Você, ligeiro, pede NS1 e hemograma, já pensando na dengue. O NS1 vem reagente, hemograma normal, dengue sem sinais de alarme. Mas aí você examina direitinho e percebe que a paciente tem uma dor abdominal importante e persistente, que não passou com analgesia endovenosa. E agora, o que fazer com essa paciente? Vem comigo que você vai descobrir.

Dengue: A Base de Tudo

Dengue vai cair na sua prova, pode ter certeza. O Brasil é dengue. No início do ano, todas as bancas querem saber se você tem habilidade de manejar esse paciente. Então vamos juntos nessa.

O vetor é o famoso **Aedes aegypti**, aquele mosquitinho branco e preto. O vírus da dengue é um **RNA vírus** com quatro sorotipos diferentes: dengue 1, 2, 3 e 4. O período de incubação gira em torno de duas semanas — é o tempo que o vírus fica se multiplicando no linfonodo regional após a picada.

Ponto importante: se você teve dengue por um sorotipo, você terá proteção permanente contra esse mesmo sorotipo, mas apenas proteção transitória contra os outros três. Qual o problema disso? A **segunda infecção tende a ser mais grave**. Acabou a proteção cruzada transitória, as células de memória vão se ativar de forma exacerbada e você terá uma infecção mais intensa. A antiga "dengue hemorrágica", hoje chamada de **dengue grave**, acontece justamente nesse contexto. Fica de olho nisso.

E de onde vêm os sintomas da dengue? Guarda essa expressão: **tempestade de citocinas**. Esse termo explica praticamente tudo na dengue. Muita citocina circulando significa muita inflamação sistêmica. Daí vem a febre, a "quebra-ossos" com mialgia intensa, artralgia, cefaleia e dor retroorbitária — aquela dor clássica atrás do olho que, no Brasil, pensou nela, pensou em dengue. Há também lesão direta no fígado com hepatopatia e elevação de transaminases. E mais: destruição imunomediada somada à invasão viral da medula óssea resulta em **plaquetopenia**.

Por causa dessa tempestade de citocinas, a **permeabilidade capilar aumenta** — o vaso que deveria estar fechadinho começa a deixar vazar plasma. Parte fundamental da fisiopatologia da dengue é esse **extravasamento de líquido**. Sai líquido do vaso para o abdome e faz ascite; sai para a pleura e faz derrame pleural. Eventualmente, isso progride para choque. E se está saindo muito líquido do intravascular, o que acontece? Aumenta o hematócrito — o paciente fica **hemoconcentrado**.

A medula óssea foi invadida pelo vírus. O que acontece? Infecção viral cursa com **leucopenia** por invasão da medula, mas os linfócitos, em reação ao vírus, estarão aumentados relativamente. Pode haver também tendência à anemia por consumo medular. Os fenômenos hemorrágicos decorrem da plaquetopenia somada ao dano endotelial e à coagulopatia. A dor abdominal e os vômitos ocorrem pelo líquido no abdome, pela hipoperfusão visceral e pelo intenso estado inflamatório. E, por fim, pode ocorrer **colecistite alitiásica** — mesmo sem cálculo, o paciente tem sintomas de colecistite pelo quadro inflamatório intenso.

Linha do Tempo da Dengue: Entendendo as Fases

A dengue tem uma linha do tempo bem didática que você precisa dominar.

Fase febril (D1-D3): Começamos com a **fase febril**, que vai do dia 1 ao dia 3 de doença. Como o nome diz, predomina a febre — uma febre alta, de 39-40°C. Junto vem cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, tudo de uma vez. Sintomas gastrointestinais como náusea, vômito e diarreia são comuns. Em cerca de metade dos casos aparece o **exantema maculopapular** em face, tronco e membros, que pode acometer palmas e plantas.



Fase crítica(D4-D6): Passada a fase febril, o paciente pode melhorar ou migrar para a **fase crítica**. Muito importante aqui: por mais contrassenso que pareça, **quando a febre desaparece é quando os sintomas de maior gravidade acontecem**. A fase crítica ocorre entre o D4 e o D6 de doença. Inicia-se com a defervescência, sendo mais comum em crianças e adultos jovens. É nesse momento que começam a aparecer os **sinais de alarme**, os sinais de gravidade e as disfunções orgânicas.

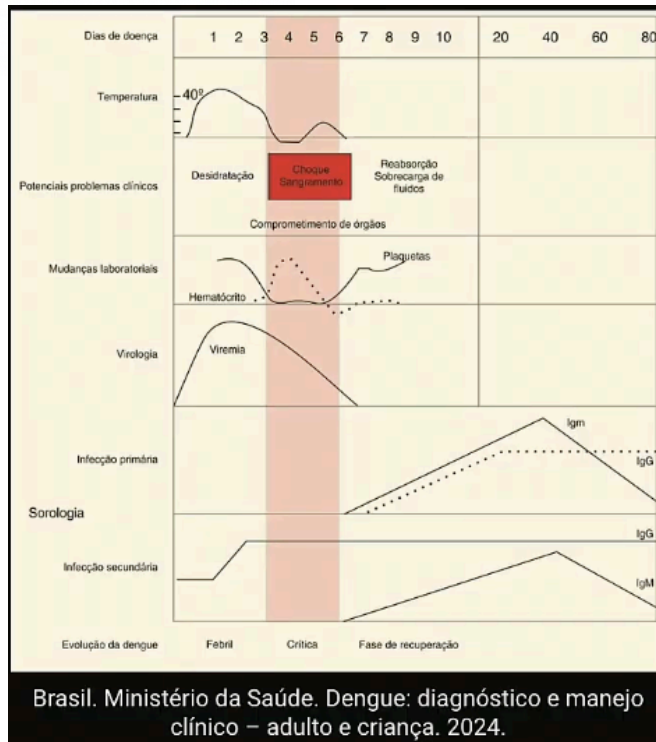
Quais são os **sinais de alarme**? Isso é uma das coisas mais cobradas em prova e você vai precisar saber na prática também: **dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural), hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 cm abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia e/ou irritabilidade (principalmente em crianças).**

A **dengue grave** é diferente dos sinais de alarme. Sinal de alarme é o que pode vir a ser grave. Grave mesmo são as repercussões daquilo tudo que conversamos: **choque hemodinâmico, derrame cavitário sintomático, hemorragia importante, acidose metabólica, CIVD e comprometimento orgânico de coração, pulmão, rim, fígado ou sistema nervoso central.**

Quais são as disfunções orgânicas típicas? A **miocardite** é muito característica — pode dar várias alterações no eletrocardiograma, arritmia, inversão de onda T e até redução da fração de ejeção. A **hepatite aguda** por lesão hepatocítica e baixa perfusão cursa com elevação de transaminases acima de dez vezes o valor de referência e RNI alargado. O quadro neurológico pode incluir meningoencefalite, Guillain-Barré e polirradiculopatias. E pode haver **injúria renal aguda**, tanto por hipofluxo quanto por ataque direto do vírus.

Fase de recuperação(>D7): Se o paciente sobreviveu a tudo isso na fase crítica, a partir do D7 começa a **fase de recuperação**. A permeabilidade capilar começa a reduzir e há reabsorção daqueles líquidos que foram extravasados. O paciente vai melhorando paulatinamente. Mas atenção: tem complicação também na recuperação. Com a reabsorção de grande volume, o paciente pode evoluir com **hipervolemia**, tanto pela reabsorção quanto pelo volume que você infundiu durante o tratamento. Além disso, por ser uma fase de redução da resposta imune, pode haver infecções bacterianas oportunistas.

Um marcador clínico de fase de recuperação é o **exantema pruriginoso**. Se o paciente chega falando que está com um vermelhão no corpo que coça muito, você pode respirar fundo — provavelmente é final de dengue.



Diagnóstico da Dengue

Primeiro, o diagnóstico é **clínico**. Febre de início súbito com duas ou mais manifestações típicas fecha o diagnóstico. As manifestações incluem: cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, artralgia, exantema, petéquias ou prova do laço positiva, vômitos e leucopenia com linfocitose relativa. Dois desses sintomas associados à febre já fecham o diagnóstico.

Quanto aos exames laboratoriais: o **NS1** é o antígeno viral presente na membrana do vírus. Ele será detectável no sangue do D1 ao D5 de doença. Já o **IgM** fica positivo do D6 ao D14, embora possa persistir por meses. Portanto, depois do D5 não adianta mais pedir NS1 porque estará negativo. Guarda isso — é muito importante.

Quando pedir esses exames? Os estoques do Ministério da Saúde não são muito abundantes, então há indicações para otimizar recursos. Em fase de epidemia, solicita-se apenas para pacientes do grupo C e grupo D. Fora de epidemia, pode-se pedir para todos os casos. E se não tiver esse exame disponível? Você fará diagnóstico pelo **critério clínico-epidemiológico**: na epidemia, paciente com febre e dois sintomas cardinais já é tratado como dengue.

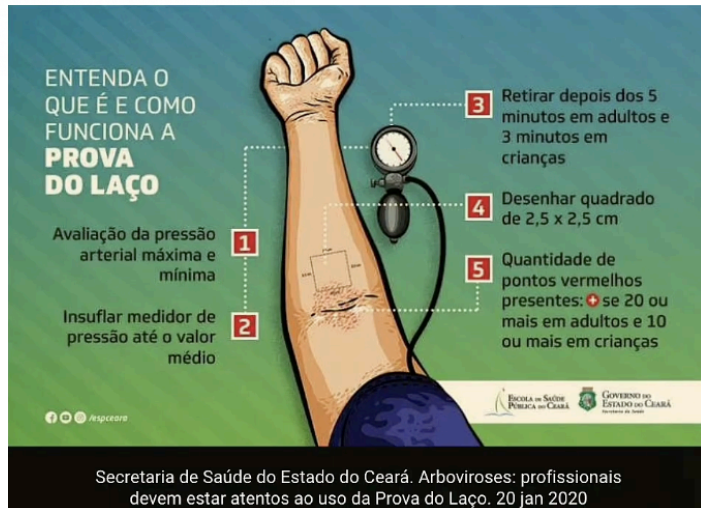
Manejo da Dengue: Os Grupos Operacionais

Vamos simplificar aquela tabelinha colorida que todo mundo vê na faculdade e ninguém entende direito.

O primeiro passo é definir se o paciente tem ou não **sinais de alarme**. Se não tem sinais de alarme, você precisa avaliar se ele tem **risco de evolução com gravidade**. Se não tem sinal de alarme nem risco de evolução, ele é **grupo A**. Se não tem sinal de alarme mas tem risco de evolução, é **grupo B**.

O que são fatores de risco de evolução? Prova do laço positiva, risco social (indígenas, moradores de rua, pessoas em situação de cárcere), cardiopatas, hipertensos, pacientes em uso de antiagregante plaquetário ou anticoagulante, idosos, gestantes, portadores de DPOC, doenças hematológicas, hepatopatias, doenças autoimunes e DRC. Esses pacientes podem complicar mais facilmente mesmo sem sinais de alarme no momento.

E a **prova do laço**, o que é? Você coloca o manguito de pressão no braço do paciente, insufla até o valor médio entre a pressão sistólica e diastólica, e deixa assim por 5 minutos em adultos ou 3 minutos em crianças. Vai ficar roxo, vai coçar, o paciente vai te xingar, mas você deixa lá. Depois, desinsufla e desenha um quadrado de 2,5 x 2,5 cm na fossa cubital. Conta as petéquias: se tiver mais de 20 em adultos ou mais de 10 em crianças, a prova é positiva. O que isso significa? Que o vasinho que deveria estar íntegro está deixando vazar sangue para a pele — há maior risco de complicação.



Manejo Clínico

Grupo A: hidratação oral com **60 mL/kg/dia**, sendo um terço com soro de reidratação oral e dois terços com líquidos claros (água, chá, melão). Orienta sinais de alarme e retorno obrigatório no quinto dia de doença.

Grupo B: iniciar hidratação oral no pronto-socorro ou UBS com 60 mL/kg e solicitar hemograma. O paciente fica em observação. Se hematócrito normal, alta com orientações do grupo A, mas com retorno **diário até dois dias após o término da febre**. Se hematócrito elevado ou surgirem sinais de alarme, muda para grupo C.

Grupo C: paciente com sinais de alarme mas sem sinais de gravidade. **Interna por pelo menos 48 horas** para hidratação endovenosa. Exames: hemograma (o hematócrito é o parâmetro mais importante), albumina, transaminases e exames de imagem conforme clínica: glicemia, função renal, gasometria, eletrólitos, coagulograma, ECOTT. A reposição começa com **10 mL/kg em 1 hora**, reavaliando após. Melhorou? Passa para manutenção: **primeira fase com 25 mL/kg em 6 horas**, depois **segunda fase com 25 mL/kg em 8 horas**. Melhorou, passou para grupo B e avalia alta. Não melhorou após até três tentativas da fase de ataque? Passa para grupo D.

Grupo D: dengue com sinais de alarme E sinais de gravidade (**choque, derrame sintomático, hemorragia importante, acidose, CIVD, disfunção orgânica**). Interna em enfermaria ou de preferência UTI. A dose é de cavalo: **20 mL/kg em 20 minutos**. Reavalia hematócrito de 15 em 15 ou de 30 em 30 minutos por 2 horas. Melhorou? Passa para grupo C. Não melhorou? Avalia a **curva de hematócrito**. Se está em **elevação** (hemoconcentrando), faz **albumina**. Se está em **queda**, o problema não é falta de volume — pesquisa hemorragia, coagulopatia, disfunção cardíaca ou hiperhidratação. Conforme necessidade, usa **concentrado de hemácias, plasma fresco, plaquetas**. Só punciona derrame cavitário se houver **tamponamento** cardíaco ou desconforto respiratório importante.

CrITÉRIOS de alta do grupo C ou D: estável hemodinamicamente por 48 horas, afebril por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas, e plaquetas em curva de elevação.

Atenção: plaquetas em elevação não significa plaquetas normais — se estava em 2.000 e agora está em 15.000, isso é elevação e pode contar para alta, desde que você reavalie conforme grupo B.

Dengue em populações especiais

Pacientes em uso de Varfarina

- **Plq > 50.000** → Controle ambulatorial de TP e contagem diária de plq
- **Plq entre 30.000 e 50.000** → Internação para controle de TP, suspender varfarina e trocar por HNF
- **Plq < 30.000** → Internação para controle de TP, suspender varfarina e deixar sem anticoagulante

Stent farmacológico < 6m ou stent convencional < 1 mês em uso de AAS e clopidogrel

- **Plq > 50.000** → Manter AAS e clopidogrel e contagem diária de plaquetas com retornos diários

- **Plq entre 30.000 e 50.000** → Manter AAS e clopidogrel e internar para contagem diária de plaquetas
- **Plq < 30.000** → Suspender AAS e clopidogrel e internação para contagem diária de plaquetas

Stent farmacológico > 6m ou stent convencional > 1 mês em uso de AAS

- **Plq > 50.000** → Manter AAS e contagem diária de plaquetas com retornos diários
- **Plq entre 30.000 e 50.000** → Manter AAS e internar para contagem diária de plaquetas
- **Plq < 30.000** → Suspender AAS e internação para contagem diária de plaquetas

Gestantes têm maior risco de abortamento no primeiro trimestre e de trabalho de parto prematuro pela tempestade de citocinas. O manejo segue os mesmos grupos e volumes — não há vantagem em fazer menos volume por ser gestante. Lembre-se do maior risco de hemorragia e acompanhe de perto.

Crianças menores de 13 anos têm volumes de hidratação oral diferenciados para o grupo A(1/3SRO e 2/3líquidos claros): até 10 kg usa-se 130 mL/kg/dia; de 10 a 20 kg, 100 mL/kg/dia; acima de 20 kg, 80 mL/kg/dia. Proporcionalmente, isso equivale a cerca de 60 mL/kg/dia para um adulto.

Cardiopatas requerem reposição volêmica cautelosa — não cabe muito volume sem risco de edema agudo de pulmão.

Vacina para Dengue: Tema Quente

Temos duas vacinas: **Qdenga** e a clássica **Dengvaxia**. A Dengvaxia está perdendo espaço e foi desincorporada do SUS em 2025.

Ambas são de vírus vivo atenuado. A Qdenga requer duas doses com intervalo de três meses. A Dengvaxia requer três doses em seis meses. A grande diferença: a **Qdenga** **independe de dengue prévia**, enquanto a **Dengvaxia** **só pode ser usada em**

quem já teve dengue — isso complica muito a logística, pois exige testagem sorológica prévia.

Ambas são indicadas para a faixa etária de 4 a 60 anos. Contraindicações por serem vírus vivos atenuados: gestantes, lactantes e imunodeprimidos. No SUS, a Qdenga está sendo aplicada prioritariamente para pré-adolescentes de 10 a 14 anos. No particular: 4-60 anos.

Outras Arboviroses: Zika, Chikungunya e Oropouche

Geralmente, as provas comparam essas doenças com a dengue, buscando nuances para diferenciá-las.

Todas são virais: vírus da dengue na dengue, zika vírus na zika, chikungunya vírus na chikungunya e oropouche vírus na oropouche. O vetor de dengue, zika e chikungunya é o *Aedes aegypti*. Já a oropouche é transmitida pelo **Culicoides** — ela sempre foi amazônica, mas começou a ter surtos no Rio de Janeiro entre 2024 e 2025, tornando-se um hot topic para provas.

Quanto à febre: dengue tem febre alta, **zika quase não tem febre** ou tem febre muito baixa, chikungunya e oropouche têm febre alta. Se a questão falar em quadro arbovirótico praticamente sem febre, pense em zika.

Todas são exantemáticas. A dengue tem exantema entre o terceiro e o sexto dia, com prurido na fase de recuperação. A zika tem um exantema leve logo no início. Chikungunya e oropouche têm exantema do segundo ao quinto dia.

Mialgia intensa: pense em dengue e oropouche. Zika e chikungunya têm menos mialgia.

Artralgia intensa: pense em chikungunya. Chikungunya significa "aquele que se curva" em um idioma africano — o paciente se curva de tanta dor articular. Oropouche também tem artralgia, mas menos inflamatória.

Conjuntivite: pense em zika. É a arbovirose "denguinha leve" com conjuntivite associada.

Hemorragia: pense em dengue. É a febre hemorrágica clássica do grupo.

Cronificação articular: apenas a chikungunya cronifica, podendo evoluir como uma artrite reumatoide com deformidades articulares.

Congênito com microcefalia: zika vírus. Todas têm potencial teratogênico, mas microcefalia é marca registrada da zika.

Febre Amarela

A febre amarela é causada pelo **flavivírus amarílico**. O vetor no ciclo silvestre é o mosquito *Haemagogus* e *Sabethes* — mosquitos de mata. O reservatório são os primatas não humanos (macacos). O ser humano é hospedeiro acidental, ocidental no ciclo silvestre. **Não existe ciclo urbano de febre amarela no Brasil desde a década de 1940** — o *Aedes aegypti* tem potencial para transmitir, mas atualmente não há essa transmissão urbana. Se houvesse, seria uma catástrofe nacional.

Para suspeitar de febre amarela na prova, precisa haver **epidemiologia compatível**: viagem para área de mata, trabalhador rural, contato com ambiente silvestre, nadou em rio no meio do mato. Se não tiver isso, dificilmente é febre amarela.

Fisiopatologia: picada do vetor -> vírus se dissemina para linfonodos -> viremia-> disseminação sistêmica

A fisiopatologia é devastadora: o vírus atinge múltiplos órgãos. No fígado: icterícia, hipoglicemia, insuficiência hepática com coagulopatia. Nos rins: necrose tubular aguda com injúria renal. No coração: bradicardia e redução do débito cardíaco. Nos vasos: fragilidade capilar com disfunção endotelial e hemorragia. Coagulopatia e plaquetopenia, que pioram a hemorragia. A viremia intensa gera tempestade de citocinas com evolução para choque.

Evolução clínica:

A febre amarela é uma **gangorra clínica**. A doença começa, (**incubação 3-6d**) parece que vai melhorar, e depois despenca para gravidade extrema.

Período de infecção (3-6 dias): início súbito de febre, calafrio, cefaléia, lombalgia, mialgia intensa, injeção conjuntival. Parece dengue/zika, só que muito mais debilitante. O sinal clássico é o **sinal de Faget**: o paciente tem febre alta, mas em vez da taquicardia compensatória esperada, apresenta **bradicardia**. Isso ocorre pelo comprometimento miocárdico.

Período de remissão (algumas horas a 48 horas): o paciente melhora, parece que vai ficar bem. Esse é o período traiçoeiro — se você liberar o paciente achando que ele está melhorando, ele volta em choque.

Período toxêmico: resposta inflamatória exacerbada com colapso hemodinâmico, febre alta recorrente, síndrome hepatorrenal com icterícia e oligúria/anúria, hemorragias graves (hematêmese, melena, epistaxe). O sinal de Faget fica ainda mais evidente. Sepses secundária é comum. A tendência é óbito em 7 a 14 dias se não houver manejo adequado.

Formas clínicas**Classificação de gravidade:**

- **Leve**(raro na prática — febre amarela geralmente é grave): sem alterações laboratoriais significativas(TGO e TGP<500, Cr<1,3, RNI<1,5)
- **Moderada**: 1 sinal de alarme sem sinais de gravidade (**sinais de alarme: TGO > 500 e creatinina > 1,3**)
- **Grave**: pelo menos um sinal de gravidade(clínico ou laboratoriais) **sinais clínicos -> Oligúria, sonolência, confusão mental, torpor, coma, convulsões, sangramento, dificuldade respiratória, hipotensão, má perfusão, icterícia; sinais laboratoriais: TGO > 2.000, creatinina > 2, RNI > 1,5 ou plaquetas < 50.000**

Marcadores laboratoriais que ajudam a diferenciar da dengue: PCR baixo (não há leucocitose importante), **TGO muito elevada** (geralmente > 2.000), **TGO maior que TGP** (porque a TGO também existe no músculo — há dano hepático E muscular), LDH muito elevado por destruição celular.

Diagnóstico: PCR até o D5, IgM a partir do D6.

Tratamento: suporte intensivo em UTI, hidratação e manejo sintomático. As opções específicas incluem **plasmaférese** (troca plasmática para remover citocinas e autoanticorpos) e **transplante hepático** em casos de insuficiência hepatocítica grave (menos eficaz, visto que as citocinas ainda estão circulantes).

Leptospirose

Leptospirose é causada pela **Leptospira interrogans**, uma espiroqueta. Essa bactéria é literalmente uma "broca" — ela gira e penetra a pele íntegra. Você pisa na água contaminada com urina de rato e o bicho fura sua pele. A Leptospira sobrevive por semanas em água contaminada e vive no trato urinário de ratos.

Epidemiologia fundamental: enchentes, esgoto, construção civil, contato com água potencialmente contaminada. Após a calamidade no Rio Grande do Sul, houve muita leptospirose.

Fases clínicas

O período de incubação é longo, de 1 a 30 dias — você pode ter contato hoje e só apresentar sintomas um mês depois.

Fase precoce (leptospirêmica): parece dengue no início, com febre, mialgia, náusea, vômito e diarreia. Mas há achados que diferenciam: **mialgia intensa em panturrilha** (e também lombar), **sufusão hemorrágica conjuntival** (olho vermelho), exantema maculopapular ou urticariforme, hepatoesplenomegalia. E, diferentemente da dengue, há **leucocitose com neutrofilia** — é bactéria. Dura cerca de uma semana.

Fase tardia (síndrome de Weil): é o que diferencia a leptospirose das outras síndromes febris. A **injúria renal aguda da leptospirose é não oligúrica e hipocalêmica** — o paciente continua urinando e não retém potássio. Isso é clássico e cai muito em prova. Além disso, há **icterícia rubínica** (mais avermelhada que amarelada, pelos fenômenos hemorrágicos cutâneos associados). A **hemorragia pulmonar** é de alta letalidade — o paciente pode sangrar maciçamente ao ser intubado. Pode haver miocardite com arritmias (FA, BAV), pancreatite, meningite e encefalite. Com a progressão, a injúria renal pode perder a característica não oligúrica.

Fase de convalescença: A eliminação da leptospira pode continuar pela urina por meses, a uveíte pode ocorrer nessa fase e continuar por meses.

Exames laboratoriais: aumento de bilirrubinas, leucocitose com neutrofilia, anemia e plaquetopenia, SARA e hemorragia alveolar no raio-X, injúria renal hipocalêmica, rabdomiólise com CK e LDH elevados, **TGO maior que TGP** (dano muscular além do hepático), alterações eletrocardiográficas. ECG: BAV, FA.

Diagnóstico: IgM por ELISA ou **MAT(microaglutinação)** em duas fases (aguda e convalescente) com aumento de títulos. Na prática, o diagnóstico é clínico-epidemiológico, mas a prova ainda gosta da microaglutinação.

Tratamento na fase precoce: antibiótico com **amoxicilina ou doxiciclina** em adultos. Em crianças e gestantes, apenas amoxicilina (doxiciclina é contraindicada).

Tratamento na fase tardia: **penicilina cristalina ou ceftriaxona** endovenosa, além de medidas de suporte.

Apelo especial sobre a diálise: se o paciente chegou com síndrome de Weil, injúria renal aguda não oligúrica e hipocalêmica, **diálise precocemente**. Não espere o paciente ficar anúrico para indicar diálise — a diálise precoce salva vidas na leptospirose.

Febre Maculosa

A febre maculosa é causada pela **Rickettsia rickettsii**, uma bactéria intracelular obrigatória. O vetor é o **carrapato-estrela** (Amblyomma), que parasita capivaras. É muito prevalente no interior de São Paulo, especialmente na região de Campinas. Se você vai prestar prova dessas bancas, maculosa é tema sempre quente.

A maculosa é grave e **muito rápida**. Diferente da leptospirose (que demora um pouco para complicar) e da febre amarela (que tem o período de remissão), a maculosa progride velozmente.

Fisiopatologia: O mecanismo é uma **infecção endotelial sistêmica**. A bactéria invade as células do endotélio vascular e causa uma **vasculite generalizada** com consumo de plaquetas, extravasamento de fluidos (edema pulmonar, cerebral, choque), disseminação intercelular gerando exantema característico, hipoalbuminemia, vasodilatação e hiponatremia. A necrose cutânea e as disfunções orgânicas (pneumonia, miocardite, encefalite) decorrem da vasculite difusa.

Quadro clínico

Incubação (5-10 dias)

Fase inicial (1-3 dias): inespecífica, com febre alta de início súbito, cefaléia, mialgia, mal estar, vômitos e dor abdominal. Exantema **ausente** nesta fase. Leucocitose e trombocitopenia leves, elevação discreta de transaminases, hiponatremia leve. Parece uma denguezinha – fácil de errar aqui.

Fase avançada (após 3o dia): evolução rápida e catastrófica. Surge **exantema petequial** (as máculas que dão nome à doença), icterícia com disfunção hepática e colestase, fenômenos hemorrágicos por vasculite e plaquetopenia, **necrose cutânea**. Sinais de gravidade aparecem rapidamente: hepatomegalia, injúria renal aguda, manifestações neurológicas, edema periférico, choque e CIVD. No laboratório: trombocitopenia importante, TGO elevada, DHL, CK, anemia e hiponatremia.

A evolução para óbito pode ser muito rápida – diferente das outras síndromes febris que dão mais tempo de manejo.

Diagnóstico: sorologia pareada (uma na fase aguda até 7 dias e outra na convalescência em 2-4 semanas após) confirma se aumento de quatro vezes nos títulos de IgG. O **PCR pode ser feito no sangue ou em biópsia de pele** – isso é importante porque às vezes não se consegue coletar sangue do paciente chocado, mas pode-se biopsiar uma lesão cutânea. Frequentemente o diagnóstico é confirmado apenas na autópsia.

Tratamento: **doxiciclina** EV ou VO é a primeira escolha. Cloranfenicol é alternativa em algumas situações (gestantes, por exemplo, embora seja menos utilizado hoje).

Resumo dos Gatilhos

Dengue

Grupo A

- Sem sinais de alarme, sem grupo de risco
- Hidratação **VO** com **SRO + líquidos claros**

Grupo B

- Risco de evolução com gravidade
- Prova do laço positiva, risco social, comorbidades
- Hidratação **VO em observação + hemograma**
 - **Ht normal:** grupo A com retorno diário até 48h afebril
 - **Ht elevado ou sinais de alarme:** grupo C

Grupo C

- Dengue com sinal de alarme, sem sinal de gravidade
- **Internação por 48h + hidratação EV**

Grupo D

- **Sinais de gravidade** → enfermaria ou UTI

Sinais de alarme

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos
- Hipotensão postural ou lipotímia
- Hepatomegalia > **2 cm** abaixo do rebordo costal
- Sangramento de mucosa
- Letargia e/ou irritabilidade

Sinais de gravidade

- Choque hemodinâmico
- Derrames sintomáticos
- Hemorragias
- Acidose metabólica
- CIVD
- Comprometimento de órgãos

Critérios de alta

- Estável hemodinamicamente por **48h**
- Afebril por **24h**
- Melhora clínica
- **Ht normal e estável por 24h**
- **Plaquetas em elevação**

Febre amarela

- **Período de infecção** → Pródromo + Faget
- **Período de remissão**
- **Período toxêmico** → Síndrome hepatorenal + hemorragias
 - **Sinal de alarme:** TGO ≥ 500 e Cr $\geq 1,3$ (moderada)
 - **Sinal de gravidade:** TGO ou TGP ≥ 2.000 , Cr ≥ 2 , RNI $\geq 1,5$, plaquetas < 50.000 (grave)
- **Diagnóstico** → PCR até D5, IgM após

- **Tratamento** → suporte

Leptospirose

- **Precoce** → mialgia e hemorragia conjuntival
- **Tardia** → Síndrome de Weil (IRA + icterícia + hemorragia pulmonar)
- **Diagnóstico** → IgM ou microaglutinação
- **Tratamento:**
 - Precoce: amoxicilina ou doxiciclina (adultos), amoxicilina em crianças
 - Quadro tardio: penicilina cristalina ou ceftriaxona

Febre maculosa

- **Inicial** → pródromo febril
- **Avançada** → icterícia, hemorragia, disfunções orgânicas
- **Diagnóstico** → sorologia ou PCR
- **Tratamento** → doxiciclina

É isso, pessoal. Sobrevivemos às síndromes febris. Dengue certamente vai cair na sua prova — domine os grupos operacionais, as doses e os critérios de alta. E lembre-se das nuances das outras doenças: cada uma tem seu gatilho clínico e epidemiológico que a prova adora explorar. Vamos juntos nessa e até a próxima aula.